

Кольпоклеизис (Закрытие влагалища)

Информация для пациента · Простая и надёжная операция при пролапсе тазовых органов

WARWIKI

Кольпоклеизис — высокоэффективная, малотравматичная операция при пролапсе тазовых органов (опущении органов малого таза): **большая часть влагалищного канала закрывается**, что постоянно удерживает органы на месте. Поскольку влагалище закрывается, операцию выбирают те, кто твёрдо решил отказаться от вагинальных половых контактов. Вмешательство короткое, щадящее и очень успешное — отличный вариант, особенно в пожилом возрасте или при сопутствующих заболеваниях.

Об этой операции

Вместо восстановления опорных тканей при кольпоклеизисе **удаляется полоска влагалищной слизистой, а стенки сшиваются**, укорачивая и закрывая канал так, чтобы органы больше не опускались. Операцию можно выполнить как с маткой, так и после её удаления. Поскольку объём вмешательства меньше, чем при других операциях по поводу пролапса, она быстрее и менее рискованна; успех достигается более чем в **90%** случаев.

Ключевой выбор

Главное, что нужно понять: после кольпоклеизиса **вагинальные половые контакты становятся невозможными** — и это постоянно. Для тех, кто в этом уверен, удовлетворённость результатом очень высока. Перед операцией врач убедится, что выбор правильный и нет других соображений (например, необходимости дополнительного обследования матки).

ТЕРМИНЫ

Пролапс

Опущение тазовых органов с ощущением выпячивания или давления.

Кольпоклеизис

Операция, закрывающая большую часть влагалищного канала для поддержки органов.

Облитерирующая операция

Вмешательство, которое закрывает (а не восстанавливает) влагалище.

LeFort

Вариант кольпоклеизиса, выполняемый при сохранённой матке.

Слинг

Опорная лента, которую иногда устанавливают одновременно при недержании мочи.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под анестезией (чаще спинальной или общей), поэтому во время неё вы ничего не чувствуете, и обычно она непродолжительна. После большинство пациентов отмечает лишь лёгкий дискомфорт и быстро восстанавливается — одно из наименее болезненных восстановлений среди операций при пролапсе.

Как подготовиться

- Будьте **уверены в своём решении** отказаться от вагинальных половых контактов.
- Соблюдайте **инструкции по анестезии** (голодание, отмена антикоагулянтов по назначению).
- Пройдите предоперационное обследование; иногда **одновременно устанавливается слинг** при недержании мочи.
- Договоритесь о сопровождении и помощи дома.

Что происходит

- 1 Вам вводят анестезию; назначают антибиотики.
- 2 Полоски влагалищной слизистой удаляются, стенки **сшиваются**, закрывая канал.
- 3 На короткое время устанавливают катетер и иногда влагалищный тампон.

После операции

- Как правило, выписка **в день операции или через сутки**; восстановление лёгкое.
- Катетер на короткое время; небольшие выделения — норма.
- **Избегайте подъёма тяжестей и натуживания** несколько недель; следите за стулом.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Обильное кровотечение
- **Невозможность помочиться** после удаления катетера
- Нарастающая боль в области таза

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Кольпоклейзис закрывает большую часть влагалища при пролапсе — быстро, очень надёжно и оптимально, когда нужна простая малорискованная операция.
2. Последствие постоянное: **вагинальные половые контакты больше невозможны** — поэтому операция подходит тем, кто в этом уверен.
3. Восстановление обычно лёгкое. Избегайте натуживания; обращайтесь к врачу при температуре, обильном кровотечении или нарушении мочеиспускания.